

Tutti attorno a un bambino autistico della scuola primaria

La guida cumulativa per l'intera équipe attorno a un bambino autistico (6-11 anni) — genitori, insegnanti, allenatori, medici, assistenti e famiglie dei pari. Una scheda di riferimento estesa; abbinatela alle guide rapide per singolo interlocutore.

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un bambino si chiude in pochi „tunnel” profondi e intensi. Quel tunnel è il suo motore — di gioia, calma, competenza e apprendimento. La vita in età scolare è rumorosa, piena di impegni e di transizioni, per cui il bambino è spesso **a serbatoio vuoto all'uscita da scuola**. Qualsiasi ruolo giochiate, la cosa singola più utile è lavorare *con* la sua attenzione: proteggete l'interesse, rendete prevedibile la giornata, abbassate il carico e date tempo per recuperare. Un approccio costante tra casa, scuola e attività moltiplica il beneficio.

Cosa aiuta in ogni contesto

- **Protegete e usate l'interesse speciale** — non trattatelo mai come un problema da gestire; è il principale regolatore del bambino e il miglior ponte verso apprendimento e connessione.
- **Rendete la giornata prevedibile** — agende visibili, avvisi prima di ogni cambio, oggetti-ponte tra le attività; mantenete gli approcci coerenti tra casa e scuola.
- **Riducete il carico sensoriale** — spazi più quieti, luce soffusa dove possibile, cuffie per i luoghi rumorosi, vestiti comodi; permettete movimento e stimming.
- **Comunicare alla lettera, una cosa alla volta**, con tempo di elaborazione; date ragioni reali per le richieste.
- **Inserite il recupero** — il tempo non strutturato e rumoroso (intervalli, pranzo) è spesso la parte *più difficile* della giornata; offrite opzioni calme e a bassa domanda.
- **Parlate con il bambino e credetegli**; condividete ciò che funziona tra i contesti (un semplice quaderno casa-scuola a due sensi previene molte brutte giornate).

Cosa evitare in ogni contesto

- Usare l'interesse come ricompensa da togliere, o „svezzare” una passione sana.
- Forzare il contatto visivo o l'immobilità come prezzo del rispetto; impedire al bambino di stimming o muoversi.
- Accumulare richieste, cambi a sorpresa o lavoro di gruppo forzato senza preparazione.
- Interpretare poche ore mascherate e accondiscendenti come „sta bene” — il costo di solito si paga dopo.

Genitori e famiglia

Casa è il **luogo sicuro** dove cade la maschera della giornata scolastica — un crollo post-scuola è un segno di fiducia ed esaurimento, non che state sbagliando. Routine stabili, un angolo quiete, interessi protetti e richieste ridotte nelle giornate difficili. Avere un piano calmo per meltdown/shutdown: abbassate il carico, non ragionate sul momento, tenete tutti al sicuro. Prendetevi cura dell'intera famiglia, fratelli compresi.

Insegnanti e educatori di sostegno

Rendete **l'interesse speciale la spina dorsale dell'apprendimento** — lettura, scrittura, matematica e argomenti *attraverso* di esso. La prevedibilità (agenda, „ora/dopo”, avvisi di transizione) abbassa il carico; proteggete focus e flusso; fornite un luogo quiete per intervallo e sovraccarico. La resistenza ai cambi è **inerzia**, non sfida. Collaborate da vicino con i genitori (gli esperti) e il referente BES/INCLUSIVE.

Allenatori e responsabili di attività

Usate un **riscaldamento e una routine prevedibili** ogni sessione; mostrate, non solo spiegate; date **una breve istruzione alla volta** con un momento per elaborare. Riducete il rumore improvviso (segni con le mani, battete quieti); permettete cuffie e movimento tra le prove. Costruite prima **la relazione** — un bambino che si fida di voi supererà di più. Celebrate l'impegno e l'interesse; l'obiettivo a questa età è un bambino che *vuole tornare la settimana dopo*.

Medico di famiglia e professionisti sanitari

„A posto a scuola, crollo a casa/ambulatorio” è comune. Chiedete del **carico scolastico e del recupero**, non solo dei sintomi; offrite la fascia più quiete, un modulo pre-visita (AASPIRE AHAT) e informazioni scritte. State attenti al **burnout/„regressione”** — riducete le richieste, non spingete. Cercate ansia, ADHD/AuDHD, problemi di sonno e gastrointestinali co-occorrenti; prendete sul serio la preoccupazione dei genitori.

Assistenti e caregiver

Mantenete costanti routine, personale e sequenza; conservate gli oggetti e gli interessi del bambino; indagate prima **dolore e sovraccarico** per ogni nuovo malessere. Avere un piano calmo per meltdown/shutdown (riducete gli stimoli, assicurate la sicurezza, nessuna contenzione). Documentate un profilo sensoriale/comunicativo individualizzato e condividetelo con la famiglia.

Pari, amici e loro famiglie

Siate modello della postura della **doppia empatia** — le differenze sono differenze, non deficit. Un amico accogliente batte un calendario sociale fitto; il gioco guidato dall'interesse, fianco a fianco, connette meglio della pressione faccia a faccia. Non forzate il contatto visivo o le „chiacchiere” tipiche; invitate il bambino alle sue condizioni e proteggete il suo tempo di pausa.

Un calo improvviso nelle competenze segnala di solito **sovraccarico/burnout**, non abilità perduta — rispondete riducendo le richieste e ripristinando riposo e interessi, contemporaneamente in *tutti* i contesti. Fate pressione a scuola (referente BES/INCLUSIVE, uno spazio quiete, apprendimento guidato dall'interesse). State attenti ad **ansia**, **evitamento scolastico e bullismo**. Cercate il supporto familiare guidato da persone autistiche e una comprensione dell'autismo inquadrata in positivo per fratelli e pari.

Se il bambino è una femmina

Le bambine di questa età camuffano pesantemente e sono spesso trascurate — la bambina quieta, accondiscendente, „perfezionista ansiosa” può essere un bambino autistico esausto. Fidatevi dell'istinto della famiglia in ogni contesto e spingete per la valutazione se si mostra solo una superficie mascherata.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — **Crescere in modo monotropico** (Parti 1–5), la guida per la **famiglia** (Parte 3), la guida **Pratici e sanità lungo l'arco di vita** (Parti 3.2 e 4) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima („bambino autistico”). **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Adattatela al singolo bambino; voi e la famiglia lo conoscete meglio.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2019, *Monotropism at School*; 2022, routine; 2023); Wood (2019, interessi intensi e inclusione); BERA (2021, flusso); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Reframing Autism (2023); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space); AASPIRE AHAT. Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.